

# SKILLS NERFS CRANIENS

## 1) NERF OLFACTIF

### Test Olfaction :

Bouchez une narine du patient **avec votre pouce** et faites sentir une odeur (café, fruits, ce que vous avez sous la main → ATTENTION : évitez les substances irritantes type sterilium.

### Tips :

Cause la plus fréquente d'anosmie = rhume  
Première plainte du patient anosmique = perte de goût

## 2) NERF OPTIQUE

### Test Acuité visuelle :

- L'acuité visuelle : se teste avec les lunettes du patient !

### Test Fond d'œil :

Réglez l'ophtalmoscope suivant votre vue et celle du patient

ex : si vous avez -6 de myopie et que la patient a -4 → faites +10 sur l'ophtalmoscope (chiffres rouges!).

Si le patient a +3 d'hypermétropie et vous +2 mettez -5 sur l'ophtalmoscope (chiffres noirs)

→ le plus simple est de régler quand vous êtes à l'œil du patient car ils ne connaissent pas forcément leur vue!

- Ophtalmoscope à l'œil gauche de l'opérateur pour regarder dans l'œil gauche du patient, puis œil droit sur œil droit.
- Dire au patient de fixer un point au fond de la salle pendant tout l'examen.
- Arrivez à l'œil du patient de biais avec l'ophtalmoscope pour éviter de provoquer un puissant réflexe photomoteur
- Trouvez un vaisseau et le suivre jusqu'à la papille optique

### Test Tâche Aveugle :

- Délimitez la tâche aveugle (= emplacement de la papille optique, où sort le nerf optique de l'œil)
- La tâche aveugle se trouve à environ 30 degrés dans votre champ visuel latéral
- Fermer le même œil que le patient
- Montrez au patient un point dessiné (ou un petit objet) que vous tenez à équidistance entre vous et le patient quand le point disparaît de votre champ de vision ainsi que de celui du patient : vous y êtes. Si la tâche aveugle du patient est agrandie par rapport à la vôtre cela peut signer un œdème papillaire par exemple.

### Test Champs Visuels :

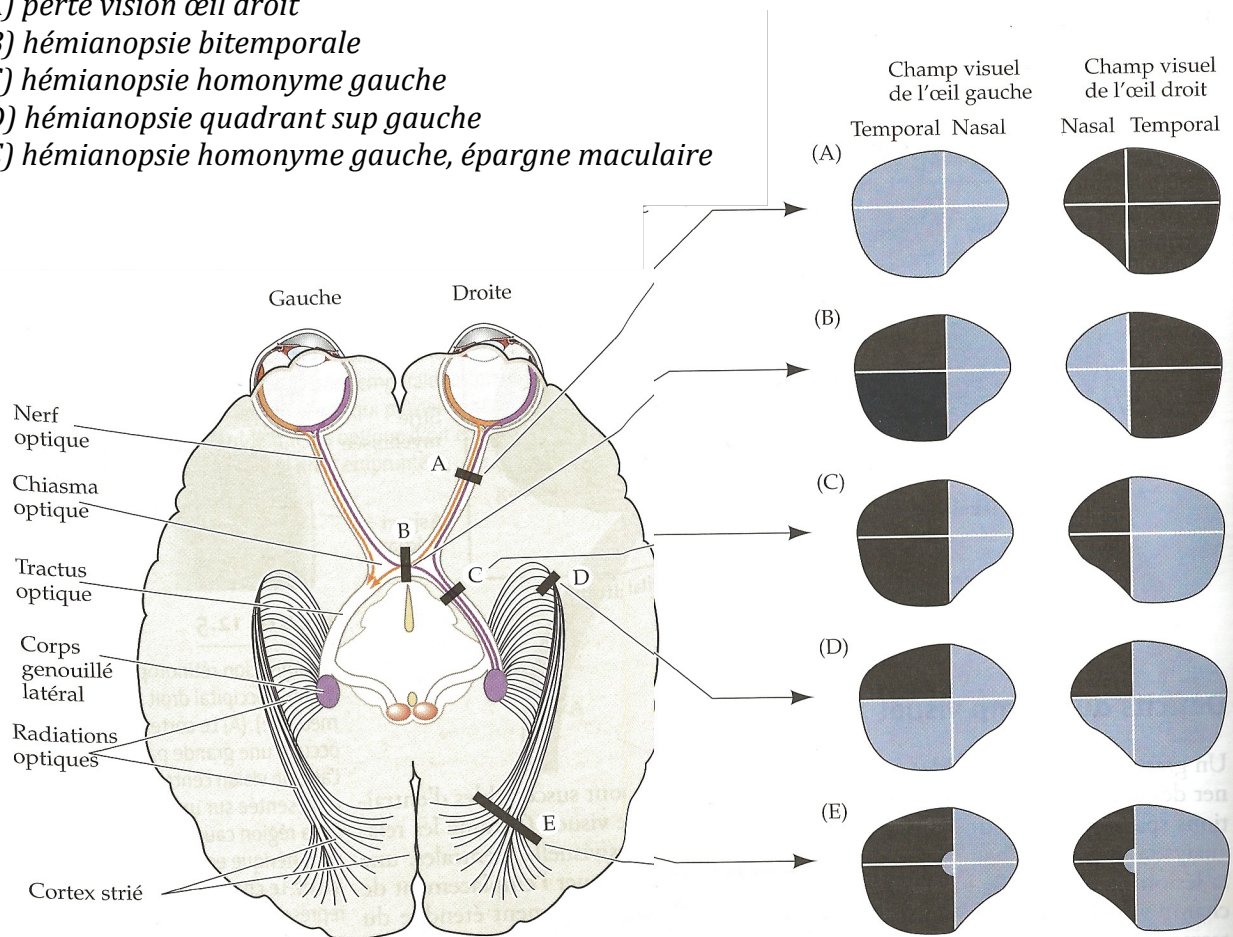
- Se mettre à la **même hauteur** que le patient

- Dire au patient de fixer son œil.
- Cachez le même œil que le patient (~~gauche - gauche / droit - droit~~)
- Placez votre main à équidistance entre le patient et vous
- Délimitez les champs visuels (avec un stylo ou vos doigts qui bougent)
- Montrez des chiffres dans chaque quadrant du champ visuel

Cachez votre œil droit et demandez au patient de cacher son œil gauche et inversement !!

### Rappel déficits :

- A) perte vision œil droit
- B) hémianopsie bitemporale
- C) hémianopsie homonyme gauche
- D) hémianopsie quadrant sup gauche
- E) hémianopsie homonyme gauche, épargne maculaire



### Tips :

Pour l'examen des champs visuels :

<https://www.youtube.com/watch?v=2-9FVywV2j4>

### 3) 4) 6) NERFS OCULOMOTEUR, TROCHLEAIRE, ABDUCENS

#### Nerf oculomoteur innervation :

m. releveur de la paupière  
m. droit supérieur  
m. droit inférieur  
m. droit médial  
m. oblique inférieur (= petit oblique)

#### Nerf trochléaire innervation :

m. oblique supérieur (=grand oblique)

#### Nerf abducens innervation :

m. droit latéral

#### Test Pupilles :

- Observez le diamètre des pupilles, anisochorie physiologique jusqu'à 1mm.
- **Réflexe photomoteur direct** : éclairez l'œil gauche avec une lampe de poche, observez la contraction de la pupille, faites de même pour l'œil droit
- **Réflexe photomoteur consensuel** : éclairez l'œil gauche et observez la contraction de la pupille du côté droit. Faites de même pour l'autre œil.
- **Réflexe convergence – accommodation** : faites loucher le patient en lui demandant de fixer un stylo (ou votre doigt) que vous approchez de son nez. Observez la contraction des pupilles au moment de la convergence.

#### Tips :

- Réflexe pupillaire afférence= nerf optique
- Réflexe pupillaire efférence = nerf oculomoteur

Ainsi, une réponse directe de l'œil gauche sans réponse consensuelle de l'œil droit fait envisager une lésion du nerf oculomoteur ou du noyau d'Edinger-Westphal.

Par contre, l'impossibilité d'obtenir une réponse en stimulant l'œil gauche, alors que les deux yeux répondent normalement à la stimulation de l'œil droit, oriente vers une lésion au niveau du nerf optique ou de la rétine.

#### Test Motilité Oculaire :

- poursuite oculaire : demandez au patient de fixer votre stylo (en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les deux diagonales)
- saccades oculaire : demandez au patient de fixer votre stylo puis votre nez, puis votre stylo etc. (en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les deux diagonales).

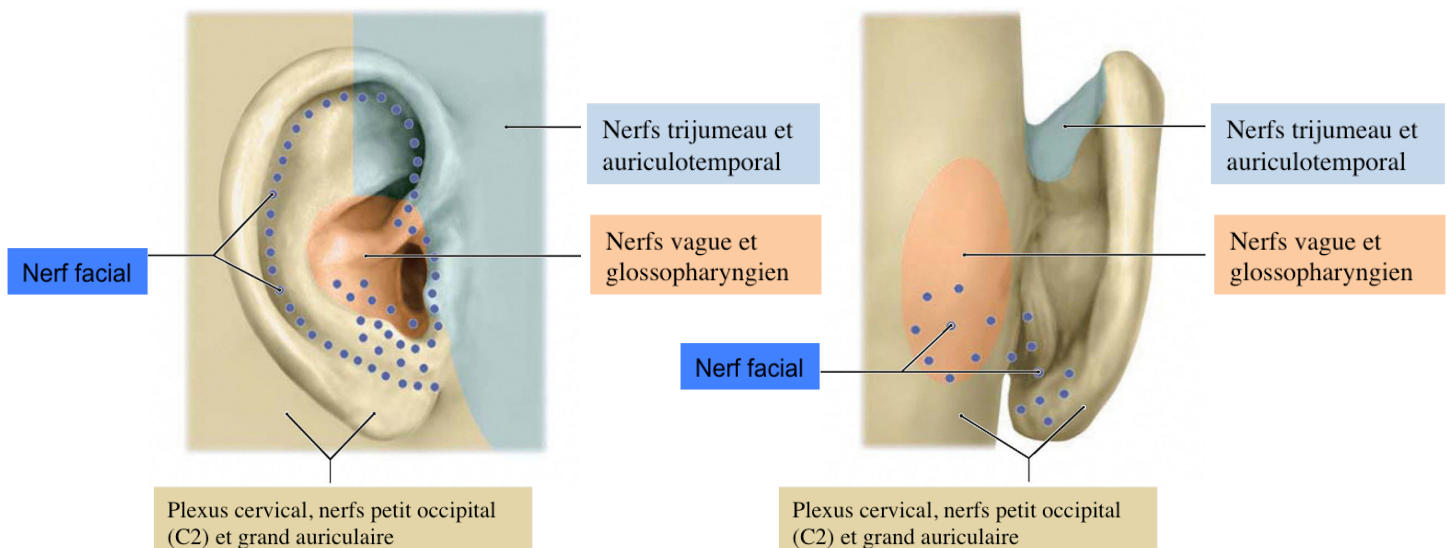
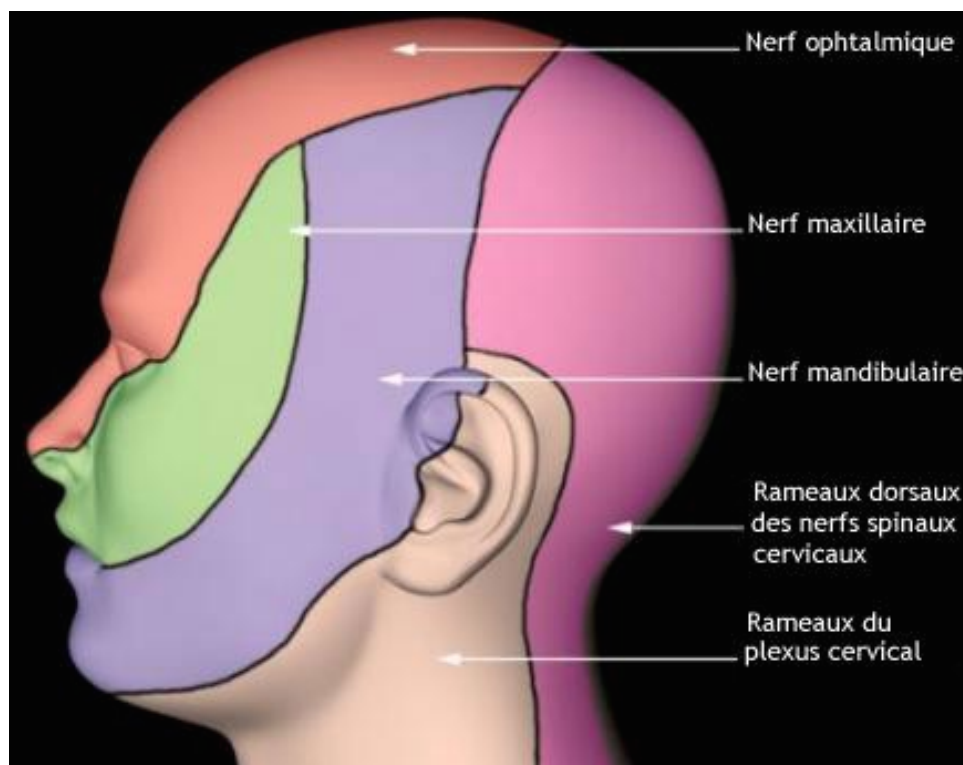
## 5) NERF TRIJUMEAU

### Test Sensibilité :

- Touchez le visage du patient en haut, au centre et en bas (vous investiguez ainsi la sensibilité transmise par les 3 branches du nerf → ophtalmique (V1), maxillaire (V2), mandibulaire (V3). Est-ce que le patient à la même sensibilité des deux côtés du visage ?

### Tips :

- innervation sensitive visage et oreille :



### **Test Réflexe Cornéen :**

- Enlevez les lentilles du patient
- Avec un coton, touchez la cornée du patient en venant depuis le côté latéral de l'œil.
- Un clignement des yeux signe un réflexe normal

### **Test Réflexe Masséterien :**

- Demandez au patient d'ouvrir légèrement la bouche
- Placez vos doigts sur son menton
- Avec un marteau réflexe, tapez sur vos doigts pour déclencher le réflexe

### **Test Muscles Masticateurs :**

- Placez vos mains sur les muscles temporaux du patient
- Demandez lui de serrez les dents, vous devriez sentir une contraction de ces muscles
- Placez ensuite vos mains sur les muscles masséter
- Demandez au patient de serrer les dents, vous devriez sentir une contraction de ces muscles

## **7) NERF FACIAL**

### **Test Mimique, Motricité Volontaire :**

- Demandez au patient de d'élever les sourcils
- Demandez au patient de froncer les sourcils
- Demandez au patient de fermer très fort les yeux
- Demandez au patient de sourire
- Demandez au patient de gonfler les joues
- Faites faire ces mimiques au patient contre résistance si doute

### **Tips :**

- paralysie centrale → front se contracte, œil se ferme
- paralysie périphérique → front reste lisse, difficulté à la fermeture l'œil  
*Causes si unilat : idiopathique (= De Bell), traumatique*  
*Causes si bilat : Guillain-barré, maladie de lyme, myasténia gravis*

### **Test Goût :**

- 2/3 antérieurs de la langue !
- Maintenir la langue du patient à l'extérieur de sa bouche
- Séchez la langue

- Posez un coton tige imbibé de substance salée / sucrée / amère / acide sur la langue du patient
- Demandez au patient **en maintenant sa langue à l'extérieur de la bouche d'écrire** quel goût il a senti.

## 8) NERF VESTIBULOCOCHLEAIRE

### Test Audition

- Appuyez sur le tragus du patient
- Chuchoter quelque chose dans l'oreille controlatérale  
     → Son aigu (sifflant) = 5, 6, 55, 66, 56, 65  
     → Son grave (roulant) = 2, 3, 33, 32, 23, 22
- Test de Weber (latéralisation du côté atteint si surdité de transmission, du côté sain si surdité de perception).
- Test de Rinne

### Test Vestibulaire

- Halmagyi (=Head Trust)
- Hallpike

## 9) 10) NERF GLOSSOPHARYGIEN, NERF VAGUE

- La phonation est-elle normale ?
- Problème de déglutition ?

### Test Sensibilité :

- Goût 1/3 postérieur de la langue
- Sensibilité fond de gorge

### Test voile du palais :

- Demandez au patient d'ouvrir la bouche et de dire « AAAAA »
- Munissez-vous d'un abaisse-langue
- Regarder la luette → si il y a une atteinte elle part du côté sain !!

### Tips :

- Bien regarder la luette pour diagnostiquer une atteinte et pas le fond de gorge !! Car si le patient à une amygdale en moins par exemple il peut y avoir une déviation du voile du palais d'un côté mais pas de la luette !

### **Test Réflexe pharyngé :**

- Maintenir la langue avec un abaisse-langue
- Avec un coton frotter les piliers antérieurs (déclenchement du réflexe chez les patients sensibles
- Faire de même sur les piliers postérieurs → déclenchement du réflexe pharyngé (nauséux).

## **11) NERF ACCESSOIRE**

### **Test Muscle Sterno-cléido-mastoïdien :**

- Appréciez la force du SCM en demandant au patient de tourner la tête contre votre main.
- La contraction unilatérale d'un muscle SCM tourne et incline la tête du côté opposé.

### **Test Muscle Trapèze :**

- Appréciez la force du trapèze en demandant au patient de hausser les épaules contre vos mains
- Appuyez fermement sur les épaules de votre patient car le trapèze est un muscle doté d'une grande force et pour que cet examen soit considéré comme normal, un mouvement actif doit être perçu malgré une forte résistance.

## **12) NERF HYPOGLOSSE**

### **Test Langue :**

- Observez la langue : motilité, trophicité, fasciculations
- Demandez au patient de tirer la langue → la langue est déviée du côté atteint si dysfonction du nerf 12.